جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : سهام محمد احمد العفيفي
المحافظة : البحيره **الحي / المدينة :** كوم حماده **العنوان :** ----
رقم البطاقة : 28105041801621 **رقم التليفون :** 01064070670 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 19-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 04-05-1981 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سهام محمد احمد العفيفي
National ID: 28105041801621

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

كود المستشفى: **102233**

وزارة الصحة و السكان
الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة
جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

فاتورة علاج رقم ٢٢٨٣٨٩٣٣

تقر مستشفى جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * بأن أصول مستندات الصرف ومؤيداتها القانونية صحيحة وعلى مسئوليتنا.
وتم حفظها بغرفة الحفظ لدينا وتحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات واننا لم ولن نتقدم بتلك الفاتورة لأي جهة اخرى للصرف.

اسم المريض سهام محمد احمد العفيفي الرقم القومي ٢٨١٠٥٠٤١٨٠١٦٢١
قرار وزاري رقم ٢٠٢٦٣٩٩٨٢٦٧٦ بتاريخ ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ بمبلغ ١٠٠٠ مدة القرار ١٨٠ يوم
تاريخ الفاتورة ٢٠٢٦-٠٩-٠٩ التشخيص سرطان بالثدي (مبادرة)
الإجراء مزيد من الابحاث و الاشعات الخصم (%) ٠

مدين	بيان	كمية	وحدة	تاريخ الصرف	ملاحظات
٢١٠	هيموجلوبين سكري	1		09/09/2026	
٢١٠	الاجمالي				

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الموظف المختص المراجع رئيس حسابات المرضى مدير الشئون المالية

نرمين رمضان محمد كيلانى ندى حسن

GRI-E جوستاف روسي جوستاف روسي - مصر

كود المستشفى: 102233

وزارة الصحة و السكان

الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

فاتورة علاج رقم ٢٣١٥٧٤٢٠

تقر مستشفى جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * بأن أصول مستندات الصرف ومؤيداتها القانونية صحيحة وعلى مسئوليتنا.
وتم حفظها بغرفة الحفظ لدينا وتحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات واننا لم ولن نتقدم بتلك الفاتورة لأي جهة اخرى للصرف.

اسم المريض سهام محمد احمد العفيفي الرقم القومي ٢٨١٠٥٠٤١٨٠١٦٢١
قرار وزاري رقم ٢٠٢٦٣٩٩٨٢٦٧٦ بتاريخ ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ بمبلغ ١٠٠٠ مدة القرار ١٨٠ يوم
تاريخ الفاتورة ٢٠٢٦-٠٩-٣٠ التشخيص سرطان بالثدي (مبادرة)
الإجراء مزيد من الابحاث و الاشعات الخصم (%) ٠

مدين	بيان	كمية	وحدة	تاريخ الصرف	ملاحظات
١٥٠	صورة دم كاملة	1		30/09/2026	
١٦٠	تي اس اتش	1		30/09/2026	
١١٠	كالسيوم كلي	1		30/09/2026	
٧٠	كرياتنين	1		30/09/2026	
٤٩٠	الاجمالي				

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الموظف المختص المراجع رئيس حسابات المرضى

GRI-E
مدير الشئون المالية
جوستاف روسي
جوستاف روسي - مصر

نرمين رمضان محمد كيلانى ندى حسن





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

02/21/2026

MDT FORM

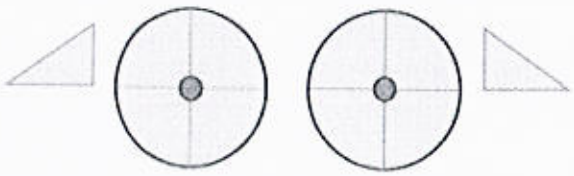
Name:	Seham Mohamed Ahmed	**MRN:**	1572
Age:	45 Y	**ID:**	
Menopausal Sta	Premenopausal	**Phone:**	01009567548
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
CO Morbidity:		**Reason Of MDT:**	Bleeding

Clinical Data:

BX: IDC

ER: 5/8 **PR:** 2/8 **HER2:** 1+ **KI67:** 25%

R L



Sonomammography:

Mets Workup:

History:
Breast, NOS: Infiltrating duct carcinoma, NOS received 4EC-->4 cycle taxotere 28/8/2024 -->CR (OUTSIDE) - T2 N0 post LT WLE+SLNB :free margins LN 0/3 pCR ADJ NOLVADEX for 1year and 2 months PORT

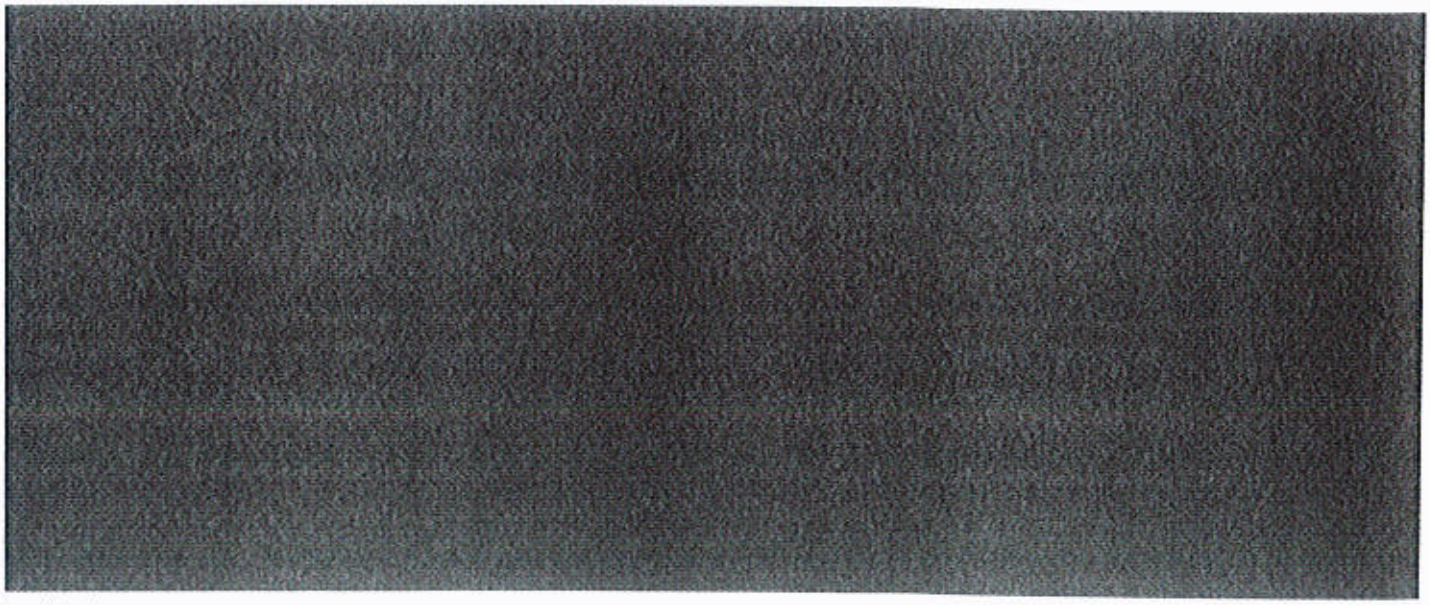
Recommendations:
- Bilateral SM: Birads 2
?Patient shifted to letrozole 2 months ago --> still complaining from bleeding (Menstruating? Fibroid?)
To shift to Zoladex + Letrozole

MDT Outcome & Plan
E2 level if menopausal go for D/C
shift to femara/ zoladex if premenopausal

TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ هناء حرب					



MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: سهام محمد احمد **MR. :** 1572	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was noted to have bilateral breast findings classified as BIRADS 2. Two months prior, therapy was changed to letrozole; however, the patient continued to experience vaginal bleeding, raising concern for ongoing menstruation or a uterine fibroid. The plan was to transition to a combination of Zoladex and letrozole.

At the subsequent visit, the patient received the first dose of Zoladex in addition to ongoing letrozole. Bleeding persisted. Laboratory evaluation for FSH and estradiol (E2) was ordered, along with a pelvic MRI. The patient reported arthritic and bony pain. Dental evaluation was recommended, and preparation to initiate zoledronic acid (Zometa) every six months was discussed.

The patient was continued on letrozole (Femara) with monitoring of the breast. A transvaginal ultrasound was performed, revealing a uterine fibroid and a left ovarian cyst.

A DEXA scan was ordered, and the patient was advised to start Prolia pending approval from the Ministry of Health (MHR).

Imaging review included a CT chest/abdomen/pelvis performed in May 2026, a brain MRI and whole-spine MRI performed on 3 August 2026, and a bone scan. Findings demonstrated L5/S1 spondylolisthesis, multiple cervical disc disease, and osteopenia of the lumbar spine with a T-score of −1.4. The patient had completed dental work two months earlier and expressed a strong desire to receive Prolia, which the provider agreed to pursue through the Ministry of Health. Endocrine therapy with Zoladex and an aromatase inhibitor, supplemented with calcium and vitamin D, was continued. The patient was counseled to consolidate care within a single institution and scheduled for the next Zoladex injection on 9 September 2026.

The most recent assessment documented osteopenia with a T-score of −1.8 on DEXA. A mammogram was performed, confirming BIRADS 2 findings. The patient remains on Zoladex and letrozole, with the regimen continued for three months at this time.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : محمد رضا أبو اليزيد كيلاني

يعتمد ,

Patient Name	:الأستاذة / مروة محمد [illegible]	Request No.	: 15009478
Patient No.	:28105041801621	Request Date	: 17/10/2024
Path No.	:3987/24	Verification Date	: 28/10/2024
Sex	:Female	Financial Category	: [illegible] - [illegible]
Age	:43 Y	Department	:Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	:Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Left WLE and SLNs.

Gross Examination:
1-Left SLN: A fibro fatty tissue piece measured 4x4 cm entangling 3 nodules up to 2.3x1.5 cm.
2-Left WLE specimen measured 8.5x7.5x4.5 cm, with covering skin ellipse measured 4.5x2.5 cm
* Tumor extent: An ill-defined rubbery grayish white tumor bed site (fibrotic).
- Size: 4.5x3.5x1.5 cm
* Skin involvement: Unremarkable grossly.
* Distance from margins: 0.1cm from both medial and suprior margin, 0.7 cm from deep margin, 1cm from inferior margin and 3cm from lateral margin.
3-Extramedial margin: A fibro fatty tissue piece measured 4x4 cm.

Microscopic Examination:
* Left breast, WLE and SLNs biopsy:
* Histological Type: No evident invasive tumor tissue(totally burnt out).
* Ductal carcinoma in situ: No.
* Skin involvement: Free.
* Lymph node involvement: Negative SLNs (0/3).
* Angioinvasion: No.
* Perineural invasion: No.
* Resection Margins: Extra-medial margin: suspicious for Atypical ductal hyperplasia. Other margin free.
* Histologic response to therapy: Complete pathological response to therapy.
Frozen section result: Extra-medial margin: suspicious for atypical ductal hyperplasia, Other

Verified by:
DR.Menna Nabil

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt
غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	:الدكتور / مريم محمد السيد شرقي	Request No.	:13009478
Patient No.	:28105041801021	Request Date	:17/10/2024
Path No.	:3987/24	Verification Date	:28/10/2024
Sex	:Female	Financial Category	:تأمين الرئاسي للسيدات - فئة فضية
Age	:43 Y	Department	:Out Patient
Referring Doc.	:	Registered by	:Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

margins free & Free SLNs (0/3).

Diagnosis:
Left breast, WLE and SLNs Biopsy:
No evident invasive tumor tissue(totally burnt out).
Free margins.
Free skin.
Lymph nodes status S.LNs (0/3).
Complete pathological response to therapy.
Stage: ypT0, ypN0.

Signature
Dr. Rana Fathy.
Dr. Samia Ali.

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (٤) - الدور الأول - مبنى رقم (٩٨٦) - كورنيش النيل - مبنى الكلية - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor- Building No. 986 - Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : [illegible] Sex: 3- Medical number: Female 83165171

2-ID number:

Patient Age : 44 Y

Family history	[illegible]	Phone	01000563548	BMI	[illegible]	REASON OF VISIT	[illegible]
marital status	[illegible]	KNS Score	[illegible]	GROUP	[illegible]	Date of Visit	[illegible]
Co-morbidity	[illegible]	Menopausal status	[illegible]	Initial STAGE	[illegible]		

Clinical data

Breast Imaging :	Mets Workup :
MRI breast LT UIQ mass	pet ct:free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	KI67
IOC	3/8	2/8	1		30

T	N	M

Sonomammography

PATIENT HISTORY

rceived 4EC-->4 cycle taxotere 28/8/2024 -->CR (OUTSIDE)
post LT WLE+SLNB :free margins
LN 0/3
pCR

MDT OUTCOME & PLAN

FOR ADJ NOLVADEX
PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	[signature]	RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	:الأستاذة / سهام محمد احمد الحايلى	Request No.	:13009478
Patient No.	:28105041801621	Request Date	:17/10/2024
Path No.	:3987/24	Verification Date	:28/10/2024
Sex	:Female	Financial Category	: [illegible] - تكلفة الدولة
Age	:43 Y	Department	:Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	:Mrs.Mayada Hogary

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Left WLE and SLNs.

Gross Examination:
1-Left SLN: A fibro fatty tissue piece measured 4x4 cm entangling 3 nodules up to 2.3x1.5 cm.
2-Left WLE specimen measured 8.5x7.5x4.5 cm, with covering skin ellipse measured 4.5x2.5 cm
* Tumor extent: An ill-defined rubbery grayish white tumor bed site (wired).
- Size: 4.5x3.5x1.5 cm
* Skin involvement: Unremarkable grossly.
* Distance from margins: 0.1cm from both medial and suprior margin, 0.7 cm from deep margin, 1cm from inferior margin and 3cm from lateral margin.
3-Extramedial margin: A fibro fatty tissue piece measured 4x4 cm.

Microscopic Examination:
* Left breast, WLE and SLNs biopsy:
* Histological Type: No evident invasive tumor tissue(totally burnt out).
* Ductal carcinoma in situ: No.
* Skin involvement: Free.
* Lymph node involvement: Negative SLNs (0/3).
* Angioinvasion: No.
* Perineural invasion: No.
* Resection Margins: Extra-medial margin: suspicious for Atypical ductal hyperplasia. Other margin free.
* Histologic response to therapy: Complete pathological response to therapy.
Frozen section result: Extra-medial margin: suspicious for atypical ductal hyperplasia, Other

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadeem - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Oncology Center

Date: 07/02/2024

Referring Physician: Prof. Dr.

- *Normal appearance of right breast parenchyma*
- *clear both axilla fields.*

Abdomen & Pelvis:

- *Hepatomegaly with normal FDG uptake & no metabolically active FDG avid focal lesions.*
- *Splenomegaly . showing normal FDG uptake with metabolically active FDG avid splenic focal lesion.*
- *Metabolically inactive subcentimetric abdominal, pelvic (reactive).*
- *IUCD is seen in situe.*
- *Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys & bladder.*

Musculoskeletal:

Normal FDG activity is seen along the surveyed skeleton sclerotic or lytic lesions are noted on CT.

OPINION:

- **Positive PET/CT study for:**
- **Metabolically active FDG avid left breast lower outer quadrant neoplastic mass lesions with distorted surrounding architecture for close follow up.**
- **Otherwise no metabolically active FDG avid locoregional nodal or distant metastases.**

Thank you for your reference

PET/CT Unit

Nuclear Medicine consultant
DR/Sherien Mahdy A. MD

Radiology Department
DR. Ahmed Touhamy. A

Revised by
DR/Mohamed Eman

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Oncology Center

Seham Mohamed Ahmed

10/02/2024

Dynamic Contrast Enhanced MRI Study of the Breast:

Pulse Sequences:

Pre-contrast axial T1/T2 SPIR and Sagittal T2WIs.

Post-contrast axial VIBE and Subtraction WIs.

Indication of the examination:

42 years old female patient complaining of left breast mass.

Report:

- Both breasts show mixed fibro glandular parenchyma (ACR B) with mild background enhancement.
- The left breast showing enhancing spiculated mass lesion seen at the lower outer quadrant at 4-5 o'clock measuring 4.5 x3.5 cm. It exhibits intermediate signal on T1WIs, low signal on T2WIs, bright signal on fat sat images & restricted on DWIs, with heterogeneous contrast enhancement. On plotting time signal intensity curve ,it shows type III
- Normal right breast.
- Normal nipple areola complex of both breasts
- No pathological axillary lymph nodes.

OPINION:

- Left lower outer quadrant malignant looking breast mass (BIRADS 4) for histopathological correlation.

DR. HEBA NABIL, M.D

Women imaging Consultant

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Whole body PET/CT

History and clinical data:
43 years old female patient with left breast mass (IDC).

Fasting blood glucose:
mg/dl

Technique:
Approximately one hour following the IV injection of the radiopharmaceutical, a total bod... CT was acquired from mid thigh to base of skull with the arms extended bove the h... was acquired for the purpose of anatomic localization & attenuation correction ... processed & displayed according to departmental protocol.

Report:

Hepatic Reference: max SUV = 4.1.

Head & Neck:

- *Bilateral palatine tonsillar focal lymphoid thickening (max ... 8.1).*
- *Bilateral upper deep cervical subcentimetric low grade FDG ... lymphadenopathies (max. SUV- 3.1).*
- *Bulky thyroid gland for US correlation.*
- *Bilateral lower deep cervical subcentimetric metabolically inert LNs.*
- *The brain exhibited normal FDG bio-distribution.*

Chest:

- *No metabolically active FDG avid mediastinal or hilar ... nodes are seen.*
- *There are no pleural or pericardial abnormalities.*
- *Physiologic FDG uptake is noted in the myocardium.*

Breast & axilla:

- *Metabolically active FDG avid left breast lower and ... irregular shaped neoplastic mass lesion, ... (4.7x2.2x3.7cm) with max. SUV 16. No associated ... thickening & areolar nipple retraction.*

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

Patient Name	: الأستاذه / سهام محمد احمد الطوخي	Request No.	: 13009478
Patient No.	: 28105041801621	Request Date	: 17/10/2024
Path No.	: 3987/24	Verification Date	: 28/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: [illegible] - تأمين الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegaz

Pathology Report

margins free & Free SLNs (0/3).

Diagnosis:
Left breast, WLE and SLNs Biopsy:
No evident invasive tumor tissue(totally burnt out).
Free margins.
Free skin.
Lymph nodes status SLNs (0/3).
Complete pathological response to therapy.
Stage: ypT0, ypN0.

Signature
Dr. Rana Fathy.
Dr. Samia Ali.

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]